

# ANTITÉRMICOS PEDIÁTRICOS

Cálculos corrigidos • doses por peso • conversão independente • revisão em 26/07/2026

**REGRA DE SEGURANÇA: o volume deve ser calculado pela concentração em mg/mL. Converter para gotas somente após confirmar, na bula do frasco utilizado, quantas gotas correspondem a 1 mL. Não intercambiar apresentações de concentrações diferentes.**

## 1. DIPIRONA (METAMIZOL)

**Faixa de referência desta folha:** 10–20 mg/kg/dose VO, individualizando intervalo e máximo conforme idade, peso, apresentação e protocolo. Para um teto operacional de 60 mg/kg/dia, 20 mg/kg não pode ser administrado a cada 6 horas.

**Restrição importante:** não utilizar em menores de 3 meses ou com menos de 5 kg; conferir contraindicações hematológicas, reações prévias a pirazolonas e condições clínicas.

| Apresentação           | Dose               | Fórmula em mL                                      | Checagem reversa                                   |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Solução oral 50 mg/mL  | 10 mg/kg/dose      | $\text{Peso} \times 0,20 \text{ mL}$               | $0,20 \text{ mL/kg} \times 50 = 10 \text{ mg/kg}$  |
| Solução oral 50 mg/mL  | 15 mg/kg/dose      | $\text{Peso} \times 0,30 \text{ mL}$               | $0,30 \text{ mL/kg} \times 50 = 15 \text{ mg/kg}$  |
| Solução oral 50 mg/mL  | 20 mg/kg/dose      | $\text{Peso} \times 0,40 \text{ mL}$               | $0,40 \text{ mL/kg} \times 50 = 20 \text{ mg/kg}$  |
| Solução oral 100 mg/mL | 15 mg/kg/dose      | <b>Peso <math>\times</math> 0,15 mL</b>            | $0,15 \text{ mL/kg} \times 100 = 15 \text{ mg/kg}$ |
| Solução oral 100 mg/mL | 20 mg/kg/dose      | <b>Peso <math>\times</math> 0,20 mL</b>            | $0,20 \text{ mL/kg} \times 100 = 20 \text{ mg/kg}$ |
| Solução 500 mg/mL      | 10 / 15 / 20 mg/kg | $\text{Peso} \times 0,02 / 0,03 / 0,04 \text{ mL}$ | $\text{Volume} \times 500 \text{ mg/mL}$           |

Se a solução 500 mg/mL tiver 20 gotas/mL confirmadas em bula: 1 gota = 25 mg. 10 mg/kg = peso  $\times$  0,4 gota; 15 mg/kg =  $\times$  0,6 gota; 20 mg/kg =  $\times$  0,8 gota. Preferir mL medidos com seringa quando o arredondamento em gotas distorcer a dose.

## 2. PARACETAMOL

**Dose:** 10–15 mg/kg/dose VO a cada 4–6 horas, quando necessário. Não exceder 5 administrações em 24 horas; observar o máximo pediátrico da bula e reduzir limites em hepatopatia, desnutrição, jejum prolongado ou outras situações de risco.

| Apresentação | 10 mg/kg/dose                          | 15 mg/kg/dose                           | Máximo/alerta                                  |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 200 mg/mL    | $\text{Peso} \times 0,05 \text{ mL}$   | $\text{Peso} \times 0,075 \text{ mL}$   | Confirmar gotas/mL; não exceder limite da bula |
| 100 mg/mL    | $\text{Peso} \times 0,10 \text{ mL}$   | $\text{Peso} \times 0,15 \text{ mL}$    | Usar seringa dosadora                          |
| 32 mg/mL     | $\text{Peso} \times 0,3125 \text{ mL}$ | $\text{Peso} \times 0,46875 \text{ mL}$ | Arredondar conforme seringa disponível         |

**Checagem reversa: volume (mL)  $\times$  concentração (mg/mL)  $\div$  peso (kg) = mg/kg/dose.**

**Não utilizar a regra “1 gota/kg” sem identificar a concentração e o gotejador. Produtos com o mesmo princípio ativo podem ter concentração e dispositivo diferentes.**

## ANTITÉRMICOS PEDIÁTRICOS — CONTINUAÇÃO

### 3. IBUPROFENO

**Dose:** 5–10 mg/kg/dose VO a cada 6–8 horas, quando necessário. Uso pediátrico geralmente a partir de 6 meses, conforme bula. Evitar em desidratação, hipovolemia, insuficiência renal, sangramento/úlceras gastrointestinais, hipersensibilidade a AINE e varicela; não associar rotineiramente a outro AINE.

| Apresentação       | 5 mg/kg/dose   | 10 mg/kg/dose  | Checagem reversa    |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Suspensão 20 mg/mL | Peso × 0,25 mL | Peso × 0,50 mL | Volume × 20 ÷ peso  |
| Suspensão 50 mg/mL | Peso × 0,10 mL | Peso × 0,20 mL | Volume × 50 ÷ peso  |
| Solução 100 mg/mL  | Peso × 0,05 mL | Peso × 0,10 mL | Volume × 100 ÷ peso |

**GOTAS:** não aplicar automaticamente “x20 gotas”. Usar o fator de gotejamento declarado na bula do produto específico. O cálculo primário e auditável permanece em mL.

### 4. CETOPROFENO — NÃO É ANTITÉRMICO DE PRIMEIRA ESCOLHA

**Apresentação em gotas 20 mg/mL:** quando a bula confirmar 20 gotas/mL, cada gota contém 1 mg. A posologia pediátrica de bula da apresentação em gotas é usualmente 1 gota/kg/dose (1 mg/kg/dose) a cada 6–8 horas, somente acima de 1 ano. Algumas bulas estabelecem 25 gotas/dose dos 7 aos 11 anos. Máximo diário de bula: 300 mg.

| Dose         | Fórmula em mL | Fórmula em gotas* | Checagem                        |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 mg/kg/dose | Peso ÷ 20 mL  | Peso × 1 gota     | 1 gota/kg × 1 mg/gota = 1 mg/kg |

\*Somente se 1 gota = 1 mg estiver confirmado na bula. Esta folha adota a posologia pediátrica da apresentação em gotas conforme a bula consultada.

**Evitar/individualizar:** desidratação, doença renal, risco hemorrágico ou gastrointestinal, asma desencadeada por AINE, associação com outros AINE e demais contraindicações. Utilizar a menor dose eficaz pelo menor período.

### 5. ONDANSETRONA — ANTIEMÉTICO, NÃO ANTITÉRMICO

A dose depende da indicação. **0,15 mg/kg/dose** é uma referência usada em situações específicas; não deve ser transformada em prescrição universal para todo vômito. Em gastroenterite aguda pediátrica, o uso é selecionado e pode ser off-label conforme apresentação/indicação. Avaliar QT longo, distúrbios eletrolíticos e fármacos que prolongam QT.

| Apresentação           | Concentração | Fórmula exata                     | Checagem reversa                                        |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Solução oral 4 mg/5 mL | 0,8 mg/mL    | Peso × 0,1875 mL<br>= peso ÷ 5,33 | 0,1875 × 0,8 = 0,15 mg/kg                               |
| Solução injetável      | 2 mg/mL      | Peso × 0,075 mL<br>= peso ÷ 13,33 | 0,075 × 2 = 0,15 mg/kg                                  |
| Comprimido/ODT         | 4 mg ou 8 mg | Peso × 0,15 = mg                  | Arredondar apenas conforme indicação e forma disponível |

### 6. FÓRMULAS UNIVERSAIS PARA CONFERÊNCIA

| Objetivo         | Fórmula                                          |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Dose total       | Dose (mg/kg/dose) × peso (kg) = mg/dose          |
| Volume           | Dose total (mg) ÷ concentração (mg/mL) = mL/dose |
| Checagem reversa | mL/dose × mg/mL ÷ peso (kg) = mg/kg/dose         |
| Dose diária      | mg/kg/dose × número de doses em 24 h = mg/kg/dia |
| Gotas            | mL × gotas/mL confirmadas na bula = gotas        |

# ANTITÉRMICOS PEDIÁTRICOS

Checklist de segurança e referências

## 7. CHECKLIST ANTES DE PRESCREVER

| Conferência     | Verificar                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paciente        | Peso atual, idade, indicação, alergias/reação prévia, hidratação, função renal/hepática e medicamentos concomitantes |
| Apresentação    | Princípio ativo, concentração exata em mg/mL, forma farmacêutica e dispositivo dosador                               |
| Cálculo direto  | mg/kg/dose → mg/dose → mL/dose                                                                                       |
| Cálculo reverso | mL × mg/mL → mg/dose → mg/kg/dose e mg/kg/dia                                                                        |
| Limites         | Intervalo mínimo, número máximo de doses, máximo por dose e máximo diário aplicável                                  |
| Administração   | Preferir seringa oral; evitar colher doméstica; gotas somente com equivalência confirmada                            |
| Duplicidade     | Pesquisar combinações para evitar paracetamol, ibuprofeno ou outro princípio ativo duplicado                         |

**Este material é uma folha de cálculo para uso médico e não substitui avaliação clínica, bula vigente, protocolo institucional ou individualização por idade, indicação, comorbidades e função renal/hepática.**

## 8. FONTES PRINCIPAIS CONFERIDAS

- ANVISA — Bulário Eletrônico, página atualizada em 17/05/2026.
- Prefeitura de Belo Horizonte — Boletim da Assistência Farmacêutica nº 10/2024: dipirona 500 mg/mL oral e injetável.
- Bulas brasileiras vigentes/consultadas das apresentações de paracetamol 200 mg/mL, cetoprofeno gotas 20 mg/mL e ondansetrona.
- Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos — Ministério da Saúde/ANVISA.
- Arquivo Consolidado — Receituário Pediátrico e Referências Clínicas, versão permanente de 25/07/2026.

### Links de consulta:

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/bulario-eletronico>  
[https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2024/boletim-da-assistencia-farmaceutica-n-10-21-6-2024\\_0.pdf](https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2024/boletim-da-assistencia-farmaceutica-n-10-21-6-2024_0.pdf)  
<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/protocolo-de-seguranca-na-prescricao-uso-e-administracao-de-medicamentos>  
<https://www.ache.com.br/wp-content/uploads/application/pdf/bula-paciente-paracetamol-gotas.pdf>

Revisão técnica e matemática: 26 de julho de 2026 • Versão corrigida 1.0